

10 - 5-Semiologie hanche sono maker

(0:00 - 0:07)

Rapidement. Stable, très très bien. Profonde.

(0:09 - 0:19)

Quoi d'autre ? Vous n'avez que une heure pour vous débarrasser de moi. Supportez-moi, allez-y, allez-y. Supporte le poids.

(0:21 - 0:30)

Mobile, dans les trois plans, très bien. C'est ça. Très congruente, oui.

(0:31 - 0:45)

Bien, bravo. Ah, profond. Quoi d'autre ? Comment est la vascularisation ? Allez-y.

(0:47 - 1:12)

Encerle. Rastomor, il y a des rastomors ? Et encerle ? Pardon ? Très très bien. Ça veut dire quoi ? La tête fémorale a une vascularisation terminale.

(1:15 - 1:32)

Ça veut dire quoi ? Élisée, si l'artère est lésée. Très très bien. Ça veut dire, ça sert à quoi les rastomors ? Les rastomors vasculaires.

(1:32 - 1:53)

C'est une vascularisation de suppléance. Ça sert quand ? Quand j'ai l'artère, le vaisseau principal qui est lésé, je trouve la vascularisation d'une autre voie, de suppléance. La tête fémorale, il n'y a pas cette suppléance.

(1:54 - 2:07)

Il a un cercle qui est terminal. Si maintenant, j'ai un problème vasculaire, c'est foutu pour mon articulation. Ça, c'est le grand problème de la hanche.

(2:07 - 2:23)

On va passer rapidement. Au niveau de la hanche, la hanche est constituée d'un passage entre le tronc et le membre inférieur. C'est pourquoi, vous imaginez une douleur de la hanche.

(2:24 - 2:45)

Ça peut être d'origine sciatique. Vous avez vu les scientifiques ? J'ai toujours une douleur fessière qui peut être prise pour une douleur de hanche. D'accord ? Je peux avoir une douleur des sacro-gnacs.

(2:46 - 2:57)

Je peux avoir une attaque du pépis. Je peux avoir... Il y a les douleurs inter-articulaires, les douleurs péri-articulaires maintenant. On est d'accord.

(2:57 - 3:16)

Péri-articulaire, c'est les tendineuses, douleurs locales. Est-ce que ce sont les os de voisinage, les éléments vasculos-nerveux ou bien des douleurs projetées, les neurasthèses, les articulations de voisinage. Décrire les signes fonctionnels d'une douleur.

(3:18 - 3:46)

Au niveau de la hanche, la douleur peut être ressentie typiquement dans la région inguinale et il peut y avoir une irradiation crurale. D'accord ? Typiquement, c'est une douleur dans la région inguinale avec une irradiation vers la cuisse antérieure. Rarement, il peut être ressenti au niveau fessier avec une irradiation vers l'antérieur, vers la cuisse.

(3:47 - 4:03)

Je peux la douleur sur le grand trochanter extérieur. Là aussi, elle irradie. D'accord ? Et comme elle peut être ressentie uniquement au niveau du genou.

(4:03 - 4:12)

Ce sont les quatre tableaux des douleurs de la hanche. Alors là, ce n'est pas l'irradiation neurologique. C'est la même douleur.

(4:12 - 4:26)

La même douleur, je le sens ici. Ce n'est pas les paresthésies. D'accord ? Bien sûr, là aussi, il faut chercher le caractère inflammatoire mécanique, égluchronique, retentissement.

(4:27 - 4:45)

Est-ce que sur un stationnement, la marche... La marche, ce sont des gens qui vous disent qu'ils ne peuvent même pas aller jusqu'aux mosquées. D'accord ? C'est le périmètre de marche. Je peux, pour déduire le retentissement, chez un sujet âgé ou un sujet masculin.

(4:46 - 5:09)

Est-ce que vous aimeriez aller jusqu'aux mosquées ? Pour les femmes, d'accord ? C'est le périmètre de marche qu'il va être rétréci. Ou bien, le retentissement sur les activités quotidiennes, le vélo, le chaussage, etc. L'examen clinique.

(5:10 - 5:33)

En position de haut, au cours de la marche, si on décide de faire ça en comparatif, l'inspection, je dois voir est-ce que le bassin boite. D'accord ? Si j'ai mal, je vais boiter du côté douloureux. Est-ce que j'ai des attitudes vicieuses ? Vicieuses du membre inférieur, amyotrophique, ou autres des quadratiques, comme les seps, les fessiers.

(5:34 - 5:59)

Voici la boiterie. Vous voyez ? Quand on a une marche équilibrée, le bassin est horizontal. Si j'ai maintenant mal ici, qu'est-ce que je vais faire ? On sait plutôt, quand je suis sur le membre douloureux, je ne fais pas une grande pression parce que ça va réveiller ma douleur.

(6:00 - 6:11)

C'est ce qu'on appelle une pas-esquive. D'accord ? J'essaie de ne pas forcer sur le pied pour ne pas avoir mal. C'est la boiterie.

(6:11 - 6:22)

C'est ce qu'on appelle aussi le trait des boucles. Des attitudes vicieuses. Le patient qui a mal et qui fait un flex.

(6:23 - 6:43)

Il marche en fléchissant la hanche et le tronc qui est fléchi vers le devant. La palpation, toujours. Je cherche s'il y a la chaleur, des points douloureux, un empatement ou un dépanchement.

(6:45 - 6:57)

Je peux demander au patient de me faire un appui monopodal. Quand il a mal, il ne peut pas. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome cliostatique.

(6:58 - 7:25)

Le patient en décubitus dorsal, tout simplement, je vais lui demander, il a mal au niveau de la hanche droite, je vais lui demander de faire une élévation, de décoller le talon du plan du lit. D'accord ? S'il arrive à faire ça, c'est bon. Maintenant, s'il n'arrive pas à décoller le talon, on parle du syndrome cliostatique.

(7:26 - 7:42)

Si le patient n'arrive même pas à décoller le talon, réflexe. Est-ce que ce n'est pas l'écotype ou la brume qui atteint juste après du contraire ? D'accord ? Il y a des réflexes. Vous n'êtes pas obligé de retenir.

(7:42 - 7:57)

C'est juste l'examen. D'accord ? Maintenant, mon patient arrive à faire cette élévation, je vais lui demander de garder cette position. D'accord ? Pendant 10 à 15 secondes.

(7:57 - 8:20)

S'il arrive, c'est bon. Sinon, c'est qu'il y a un problème, c'est la manœuvre de salut coxale. L'étude des mobilités passives et actives, je le dis, je le redis, pour déduire qu'un mouvement est anormal, il faut bien reconnaître le normal.

(8:20 - 8:30)

La flexion est à 120. L'extension se fait en récubitus ventral. D'accord ? Il est de 30 degrés.

(8:31 - 8:39)

Les rotations, 145. D'accord ? L'abduction, 30. L'abduction est à 40.

(8:40 - 9:02)

D'accord ? Maintenant, on reconnaît l'origine consopémorale de la douleur. C'est toujours le même schéma. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est l'articulation qui est malade ? Les deux mobilités actives et passives sont anormales.

(9:02 - 9:16)

On répète ces mots anormales, soit douloureuses, soit diminueuses, la dignité. Normal, normal, chercher, chercher ailleurs. Chercher ailleurs, ce n'est pas l'articulation.

(9:16 - 9:35)

Qui dit ailleurs ? Ça peut être le racisme, il y a le pénis, le genou. D'accord ? Normal, mobilité active normale, pardon, passive normale, et active anormale, c'est le temps d'une empathie, jusqu'à présent. Très bien.

(9:36 - 9:50)

Alors, quelques principes de pathologie. Une douleur inflammatoire, on l'a dit tout à l'heure, soit infectieuse, c'est une urgence. Alors, il y a les coccyx infectieux aigus.

(9:51 - 10:05)

C'est là où on parle de coccyx septico-infectieux, à génie biogène. Il y a les coccyx qui évoluent depuis trois mois, six mois. Vous reconnaissez ? La tuberculose, il évolue à bras à bras.

(10:06 - 10:19)

D'accord ? Il y a la brucellose, vous allez voir ça plus tard. L'origine, rematismale. Quelques exemples, la spondyloarthrite et la polyarthrite rhumatoïde.

(10:20 - 10:32)

Et les coccyx microcrystallines, c'est métabolique. Deux étiologies, la goutte, la chondrocassinose articulaire. Bien.

(10:33 - 10:47)

Douleurs inflammatoires, trois, trois grandes repères. Infectieuse, allez-y. Infectieuse, ça pourrait être aiguë, c'est dans l'arthrite septique, à biogène.

(10:49 - 11:04)

Lente ou chronique, comme la tuberculose, rematismale. Et métabolique aux microcrystallines, très bien. Mécanique, ça, je vous demande d'apprendre les exemples.

(11:05 - 11:32)

Je veux que vous appreniez ça. Douleurs mécaniques, l'arthrose, l'ostéonécrose aseptique, on en a parlé tout à l'heure au contexte où je vais avoir la rupture de la vascularisation de la tête fémorale, il va y avoir l'ostéonécrose. Pourquoi j'ai la destruction de la tête ? Parce que ça éroule à bas droit.

(11:32 - 11:53)

Ce sont des douleurs qui sont très intenses. C'est des douleurs, quand est-ce que le patient va se rendre compte quand il va se mettre à boiter ? Alors, il se met quand on fait la radio, c'est trop tard. D'accord ? C'est ça le problème de l'ostéonécrose aseptique.

(11:53 - 12:20)

La goudistrophie, la goudistrophie c'est un problème là aussi de nerveux vasculaires. Ce qui le fait, c'est surtout la femme pendant la grossesse et à la suite le traumatisme. A la suite du traumatisme, il faut être très vigilant aux douleurs mécaniques qui vont persister ou qui vont apparaître quelques mois après le traumatisme.

(12:20 - 12:32)

Il faut toujours aller faire des radiographies ou une IMS. Les autres diagnostics à évoquer, l'ostéocondromatose. L'ostéocondromatose, je vais vous montrer une image.

(12:33 - 12:44)

Et la synovite vilonodulaire, ce sont des tumeurs de la membrane synoviale. Les douleurs mécaniques de la hanche 3, grande pathologie. Arthrose.

(12:45 - 12:55)

L'ostéomicrose aseptique. A la goudistrophie, les deux autres, c'est l'ostéocromatose et la synovite vilonodulaire. Quelques exemples.

(12:57 - 13:20)

Alors, voici une radiographie normale d'une hanche. Là aussi, vous reconnaissez la tête, le col, le grand trochanter, le petit, d'accord ? Ça, c'est le labrum et l'oscoxale. La terlie, quand elle est conservée, c'est l'épaisseur du captilage, vous voyez, sur le long de l'articulation.

(13:21 - 13:51)

Regardez. Quand on a l'arthrose, qu'est-ce que vous voyez ici ? Il n'y a plus d'interligne intra-articulaire. Et comment est ce pincement ? Est-ce qu'il est global ? Voilà, très bien, parce que, regardez, vers l'intérieur, on garde une épaisseur du captilage qui est tout à fait normale.

(13:52 - 14:08)

Cet aspect blanchâtre, c'est l'ostéocondensation et regardez les ostéophytes. Regardez. Elles sont de grosses.

Elles ressemblent aux ostéophytes. D'accord ? Très bien, c'est l'arthrose. L'ostéonicrose.

(14:08 - 14:28)

L'ostéonicrose, quand on a rupture et la vascularisation, ça évolue en bas bruit. C'est la tête qui va perdre la vascularisation et qui va se mécroser petit à petit. Et à la fin, il va y avoir une perte de la sphéricité.

(14:29 - 14:48)

De la sphéricité et les stades évoluent. Une arthrose, stade 4. D'accord ? C'est ça le problème. Et comment vous pouvez ne pas arriver à là ? Dès que le patient ressent la douleur, il faut une décharge complète.

(14:48 - 15:02)

Parce que la tête, en perdant la vascularisation, elle devient très fragile, pâteuse. Avec mon poids, je marche tout le temps, elle finit par s'affaisser. C'est ça le problème.

(15:02 - 15:29)

Il fallait juste... On met les patients sur un fauteuil roulant. Le long que ça va passer. Dans les stades premiers, en 2, c'est-à-dire les traumatos, ils comblent avec ce qui a été détruit, c'est le forage.

D'accord ? Ça c'est juste un titre indicatif. Voici l'ostéochondromatose. Regardez.

(15:31 - 15:42)

Ce sont des excroissances. Des chondromes. Pourquoi ils apparaissent ? Parce qu'ils sont remplis de calcium.

(15:42 - 16:17)

D'accord ? C'est une maladie. C'est ce qu'on appelle l'ostéochondromatose. Ça, c'est une coccyte.

C'est une destruction totale de l'articulation au cours d'un rhumatisme qui est la spondylarthrite ankylosante. Est-ce que vous arrivez à voir la différence avec l'arthrose ? L'arthrose, c'est un problème localisé. D'accord ? Vous vous rappelez l'espace interne qui était encore visible à l'intérieur.

(16:17 - 16:27)

Là, c'est complètement détruit et la patiente est candidate à une prothèse de la hanche. D'accord ? Très bien, on a terminé.